TEMA 34 · Perspectiva de género en el proceso de salud/enfermedad. Morbilidad diferencial. Protocolo sanitario ante la violencia de género. Plan de Acción Regional. Malos tratos en el niño, la mujer y el anciano

Resumen OPE Enfermería SMS · Sexo y género, morbilidad diferencial (biología, ambiente, pobreza, trabajo, violencia), ciclo de Walker, LO 1/2004, protocolo común del SNS y parte de lesiones, cribado (WAST, HITS, AAS), Ley 7/2007 de Murcia y red CAVI, maltrato al anciano (Zarit, EASI) y al niño (RUMI)

1. Género y salud

- **Sexo**: características **biológicas** (genéticas, hormonales, anatómicas). **Género**: **construcción social** de roles, tareas y expectativas asignadas de forma desigual a hombres y mujeres.
- La medicina ha sido **androcéntrica** (el varón como norma). Paradoja de la **morbilidad diferencial**: **«las mujeres viven más, pero viven peor»** (más enfermedad crónica, dolor, discapacidad y trastornos mentales).

2. Determinantes de la morbilidad diferencial

- **Biológicos**: inmunidad más potente en la mujer → más resistencia a infecciones, pero **más enfermedades autoinmunes** (lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, Hashimoto). Distinta farmacocinética (más grasa, menor filtrado) y menor presencia en ensayos → **más reacciones adversas**.
- **Infarto en la mujer**: presentación **atípica** (disnea, **fatiga**, dolor epigástrico o interescapular, sin dolor opresivo típico) → **diagnóstico y reperfusión más tardíos** y mayor mortalidad.
- **Medio ambiente**: más exposición doméstica a **disruptores endocrinos** (limpieza, cosmética, plásticos): endometriosis, ovario poliquístico, cáncer de mama.
- **Pobreza**: **feminización de la pobreza** (brecha salarial, paro, temporalidad); indicador **AROPE** (riesgo de pobreza o exclusión); los **hogares monomarentales** son los más vulnerables.
- **Trabajo**:
- **Segregación horizontal**: mujeres concentradas en sanidad, educación, cuidados, comercio y limpieza: riesgos **ergonómicos** (movilizar pacientes: índice **MAPO**) y **psicosociales** (trabajo emocional, **burnout**).
- **Segregación vertical (techo de cristal)**: pocas mujeres en puestos directivos pese a que la sanidad está muy feminizada.
- **Doble presencia** (trabajo remunerado + doméstico y de cuidados): riesgo psicosocial prioritario, evaluado con el **CoPsoQ-istas21**; produce **sobrecarga alostática**: fatiga crónica, fibromialgia, colon irritable, insomnio y consumo de **ansiolíticos**.
- **Violencia de género**: la manifestación extrema de la desigualdad; secuelas físicas (dolor crónico, problemas ginecológicos y obstétricos, ITS, embarazos no deseados) y psíquicas (**estrés postraumático**, depresión, suicidio, adicciones).
- **Ciclo de la violencia de Leonore Walker (1979)**: **tres fases** (no cuatro): 1. **Acumulación de tensión** (insultos, control; ella intenta calmarle y se culpa). 2. **Explosión** (agresión; es cuando suele acudir a urgencias). 3. **Luna de miel o reconciliación** (arrepentimiento y promesas; retira denuncias y el ciclo se repite).

3. Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género

- Violencia física o psicológica (incluidas **agresiones sexuales, amenazas, coacciones y privación de libertad**) contra la mujer por parte de quien **sea o haya sido su cónyuge o pareja**, **aunque no hayan convivido**.
- Incluye la **violencia vicaria**: daño a **los hijos menores** para hacer sufrir a la madre.
- **Derechos**: **asistencia social integral** (información, atención psicológica, acogida) **sin necesidad de denuncia**; **derechos laborales** (reordenar la jornada; las **faltas de asistencia** se justifican con informe de los **servicios sociales o de salud**); **ayuda económica** de pago único si tiene **rentas bajas** y dificultad para encontrar empleo; **escolarización inmediata** de los hijos si cambian de residencia.

- Las estrategias estatales actuales amplían el foco a otras violencias machistas: sexual, ciberviolencia, acoso, **trata**.

4. Protocolo común de actuación sanitaria (SNS)

- Los servicios sanitarios son la **principal puerta de entrada**: las víctimas consultan más (AP, urgencias, ginecología, pediatría). Protocolo Común **2012**; protocolo de **mutilación genital** (2015); **instrumento común de detección temprana con WAST-corto** (2021); violencia sexual y «pinchazos» (2023).

Fase	Contenido
1. Detección	Preguntar **de forma rutinaria** (historia, embarazo), en privado y sin juzgar, y vigilar los **indicadores de sospecha**
2. Identificación	Entrevista en **privado**; si lo confirma, **exploración completa** con su consentimiento y registro detallado (hematomas **en distintos estadios**, alopecia por tirones, **fracturas defensivas** de cúbito y radio; esquemas o fotos)
3. Valoración	Salud física y psíquica, **apoyos**, tipo y duración del maltrato y **riesgo vital** (armas, tóxicos, **menores o dependientes** en casa)
4. Actuación	Tratar; **parte de lesiones al juzgado** (obligatorio **aunque la mujer no quiera denunciar**); si **riesgo vital**, **no dejarla salir**, protegerla en el centro y **llamar al 112**; **trabajo social** y derivación a recursos (red CAVI)

- **Indicadores de sospecha**: dolor crónico, cefaleas, fibromialgia, colon irritable; dolor pélvico, **ITS de repetición**, **control prenatal tardío**, abortos; depresión, ansiedad, insomnio, intentos de suicidio, abuso de psicofármacos o alcohol; **hiperfrecuentación** o, al revés, abandono de tratamientos y citas; **pareja controladora** que no la deja hablar.
- **Pareja controladora en la consulta**: **no enfrentarse** a él; usar un **pretexto técnico** (constantes, electrocardiograma) para quedarse a solas con ella.
- **Prevención**: **primaria** (igualdad y educación, evitar que ocurra), **secundaria** (**cribado y detección precoz**: WAST, EASI), **terciaria** (tratar secuelas, evitar la revictimización, derivar a la red CAVI).
- **NANDA** útiles: síndrome traumático de la violación (00142), riesgo de suicidio (00150), afrontamiento ineficaz (00069), desempeño ineficaz del rol (00055), riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062), riesgo de violencia dirigida a otros (00138).

5. Cuestionarios de cribado (mujer)

Instrumento	Claves
WAST-corto	**2 preguntas** sobre la relación: **tensión** en la pareja y **dificultad para resolver las discusiones** (mucha / alguna / ninguna). **No pregunta por golpes** ni abusos. Positivo con «mucha tensión» y «mucha dificultad»
WAST-largo	8 ítems (añade violencia física, sexual y emocional)
HITS	4 preguntas (últimos 12 meses): **H**urt, **I**nsult, **T**hreaten, **S**cream; el **E-HITS** añade la violencia **sexual**
AAS	Escala clásica en **embarazo** y consultas obstétricas

- Validación española del **WAST-corto** (390 mujeres; patrón de referencia **ISA, Index of Spouse Abuse**): **sensibilidad 91,4%**, **VPN 98,1%** (un negativo descarta casi con seguridad), especificidad 76,2% y **VPP 40,2%** → un positivo **no es un diagnóstico**: obliga a confirmar con entrevista.

6. Región de Murcia

- **Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género** (principio de **transversalidad**) y **Pacto Regional contra la Violencia de Género**.
- **Red CAVI** (Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia): atención psicológica, social y jurídica **sin exigir denuncia**.
- **SEMA**: atención psicológica a los **menores expuestos** a la violencia de género.
- Coordinación con juzgados, fiscalía, forenses y policía: **UFAM** (Policía Nacional) y **EMUME** (Guardia Civil).

- (El temario cita también la **Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021**: 3 ejes, sensibilización, atención integral y coordinación, con el registro **VISEM**.)

7. Maltrato al anciano y al niño

- **Maltrato al mayor (OMS)**: acto único o repetido, o falta de medidas, en una **relación de confianza**, que causa daño o angustia. Formas: física, psicológica, **económica**, sexual y **negligencia**. Está **infradiagnosticado** (más del 90% no se registra); el agresor suele ser **familiar o cuidador**.
- Factores: **aislamiento** (síndrome de Diógenes), **dependencia económica** del agresor, tóxicos, **sobrecarga del cuidador**.
- **Escala de Zarit** (sobrecarga del cuidador): **22 ítems**, 0-88 puntos; **≤ 46 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **≥ 56 intensa** → activar ayudas, respiro y apoyo psicológico.
- **EASI** (Índice de Sospecha de Maltrato a Mayores): en ancianos **sin deterioro cognitivo importante (MMSE ≥ 24)**, unos 2 minutos, últimos **12 meses**; **5 preguntas al paciente** y **1 observación del profesional**. La **pregunta 1 (dependencia) no puntúa**; **un «sí» en las preguntas 2 a 6** basta para sospechar y derivar a trabajo social.
- **Maltrato infantil** (ver también Tema 29): **negligencia = la forma más frecuente**; físico (lesiones incompatibles con la edad o con el relato, **fracturas en distinto estadio**, quemaduras por inmersión o con cigarrillo); **bebé sacudido** (hematoma subdural, hemorragias retinianas, sin lesiones externas); emocional; sexual; **maltrato médico (Münchausen por poderes)**: el cuidador **provoca o inventa** síntomas (es abuso activo, no negligencia).
- Alarma: **relato incompatible** con el desarrollo del niño, **retraso en consultar**, y en el niño la **«vigilancia congelada»** (hipervigilancia y miedo) o agresividad.
- **Murcia**: **Hoja de Notificación de Riesgo y Maltrato Infantil** → **RUMI**. No exige certeza. Nivel **leve**: seguimiento con el niño en casa; **moderado**: intervención de los servicios comunitarios; **grave**: protección de menores, fiscalía y policía, **separación** del niño.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Sexo = biología; género = construcción social.
! Mujeres: **viven más, pero peor**; infarto **atípico** y diagnóstico más tardío.
! Walker: **tres fases** (tensión, explosión, luna de miel).
! **LO 1/2004: pareja o expareja, con o sin convivencia; la ayuda social no exige denuncia.**
! **Parte de lesiones obligatorio aunque la mujer no quiera denunciar.**
! Riesgo vital: **no dejarla salir** y **llamar al 112**.
! Agresor presente: **no confrontar**, aislarla con un pretexto.
! WAST-corto: **tensión y dificultad** en la pareja; positivo ≠ diagnóstico (VPP 40%).
! Zarit **≥ 56** = sobrecarga intensa.
! EASI: la pregunta 1 **no puntúa**; un sí en **2-6** = sospecha.
! Münchausen por poderes = **maltrato activo**, no negligencia.